

北京市西城区人民法院

涉重疾险纠纷审判白皮书

（2021-2024）

目　录

前　言 1

主要法律法规名称一览 3

一、涉重疾险纠纷案件审理情况 4

二、涉重疾险纠纷案件特点 8

（一）重疾险具有高度专业性 8

（二）电子投保成为主流 10

（三）争议焦点集中 11

三、涉重疾险纠纷审判工作举措 11

（一）抓牢审判管理指标，全面提升审判质量新效能 12

（二）锻造高素质审判队伍，精准推进审判专业化建设 13

（三）联动多部门调解，绘就多元解纷新“枫”景 14

（四）诉前判后多措并举，营造良好金融法治环境 14

四、涉重疾险业务对策建议 15

（一）保险公司合规经营，发挥风险保障最大效能 15

（二）行业协会自律管理，激发合规展业内生动力 17

（三）消费者提高法律意识，依法维护自身合法权益 19

（四）监管司法联动作为，发挥行业治理最强合力 20

五、典型案例 21

【案例一】健康询问时保险人概括性询问的效力 21

——秦某诉某保险公司人身保险合同纠纷案 21

【案例二】投保人未如实告知与保险事故的因果关系认定 24

——冷某诉某保险公司人身保险合同纠纷案 24

【案例三】投保人询问的涵义应当严格按照文义解释确定 27

——蔡某诉某保险公司人身保险合同纠纷案 27

【案例四】两年不可抗辩条款的适用 29
——王某诉某保险公司人身保险合同纠纷案 29
【案例五】保险理赔应符合疾病诊断的最新发展 32
——李某诉某保险公司人身保险合同纠纷案 32
【案例六】以特定病症作为严重程度的限定条件效力及认定标准 34
——李某诉某保险公司人身保险合同纠纷案 35
【案例七】疾病的特定诊断方式能否作为疾病严重程度的认定标准 ... 37
——贾某诉某保险公司人身保险合同纠纷案 37
【案例八】电子投保场景下保险人免责条款提示说明义务的认定标准 ...39
——黄某诉某保险公司健康保险合同纠纷案 39
【案例九】销售人员代操作投保不能视为履行提示说明义务 42
——王某、李某诉某保险公司健康保险合同纠纷案 42
【案例十】引用重疾险等待期条款拒赔的认定 45
——王某诉某保险公司健康保险合同纠纷案 45

前　言

习近平总书记在中央金融工作会议中强调，要发挥保险业的经济减震器和社会稳定器功能。《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》对“加大保障和改善民生力度、扎实推进全体人民共同富裕”作出部署，明确要求“加强普惠性、基础性、兜底性民生建设，解决好人民群众急难愁盼问题”。

保险应当发挥社会稳定器功能，强化风险管理、分散与补偿功能，让普通家庭、低收入者、生活困难者等在遭遇重大疾病、意外事故等困难时能得到适当的经济保障，保证基本的生活生产稳定性，助力兜住、兜准、兜牢民生底线，更好满足人民群众对美好生活的向往。

北京金融街作为国家金融监管部门、主要的全国性金融行业协会和重要金融基础设施承载地，是集决策监管、标准制定、资产管理、支付结算、信息交流等功能为一体的国家金融管理中心。金融街在服务首都城市韧性安全建设、经济社会高质量发展方面起到重要的示范引领作用。

自 2017 年正式揭牌入驻金融街以来，西城法院金融街人民法庭以扎实的金融审判树立裁判规则，促进金融纠纷源头化解，积极服务保障国家金融管理中心功能建设。本次发布《涉重疾险纠纷审判白皮书（2021-2024）》，聚焦重大疾病保险理赔领域热点问题，全面梳理涉重疾险纠纷典型案件，总结提炼审判态势，探究消费者与保险公司签订重大疾

病保险合同的法律风险，提出促进保险行业健康有序发展的治理建议，将典型案件作为推动政策落地的重要载体，彰显维护金融市场秩序、保障金融安全以及保护金融消费者合法权益的司法导向。今后，随着保险行业的发展，西城法院将牢固树立强监管、防风险、促发展理念，持续提升金融审判质效，坚持审判树规则，协同促发展，为保险业高质量发展提供更有力度、温度、深度的司法保障。

编写人：北京市西城区人民法院金融街人民法庭

吕江 张岩 苏畅 刘茜倩 马莹 宋昊霖

主要法律法规名称一览

1.《中华人民共和国民法典》简称《民法典》

2.《中华人民共和国保险法》简称《保险法》

3.《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国保险法〉若干问题的解释（一）》简称《保险法司法解释一》

4.《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国保险法〉若干问题的解释（二）》简称《保险法司法解释二》

5.《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国保险法〉若干问题的解释（三）》简称《保险法司法解释三》

6.《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国保险法〉若干问题的解释（四）》简称《保险法司法解释四》

7.《健康保险管理办法》

8.《互联网保险业务监管办法》

9.《保险代理人监管规定》

10.《疾病和有关健康问题的国际统计分类》第十次修订（ICD-10）

11.《疾病和有关健康问题的国际统计分类》第十一次修订版（ICD-11）

一、涉重疾险纠纷案件审理情况

2021 年至 2024 年，西城法院金融街人民法庭共审理涉重疾险类案件 284 件，案涉标的额达 6256.88 万元。其中，2021 年至 2024 年结案数分别为 62 件、60 件、76 件、86 件，标的额分别为 1364.19 万元、1305.33 万余元、1311.43 万元、2275.94 万余元。**从案件逐年变化情况看，**涉重疾险类案件数量呈增长趋势，相较 2021 年，2024 年结案数量增长约 38.71%。（详见图 1）



图 1 结案数量及标的额情况

统计期内，重疾险案件标的额呈现波动变化趋势，平均标的额约 22.03 万元，约为北京市居民人均可支配收入[1]的 2 至 3 倍。重疾险纠纷标的额高、争议大，重疾险纠纷审理对被保险人生活具有重要影响，案件结果直接关系被保险人的疾病救治资金是否充足、生存保障是否到位。（详见图 2）

[1] 2021-2024 年北京居民人均可支配收入从 75002 元增长至 85415 元。

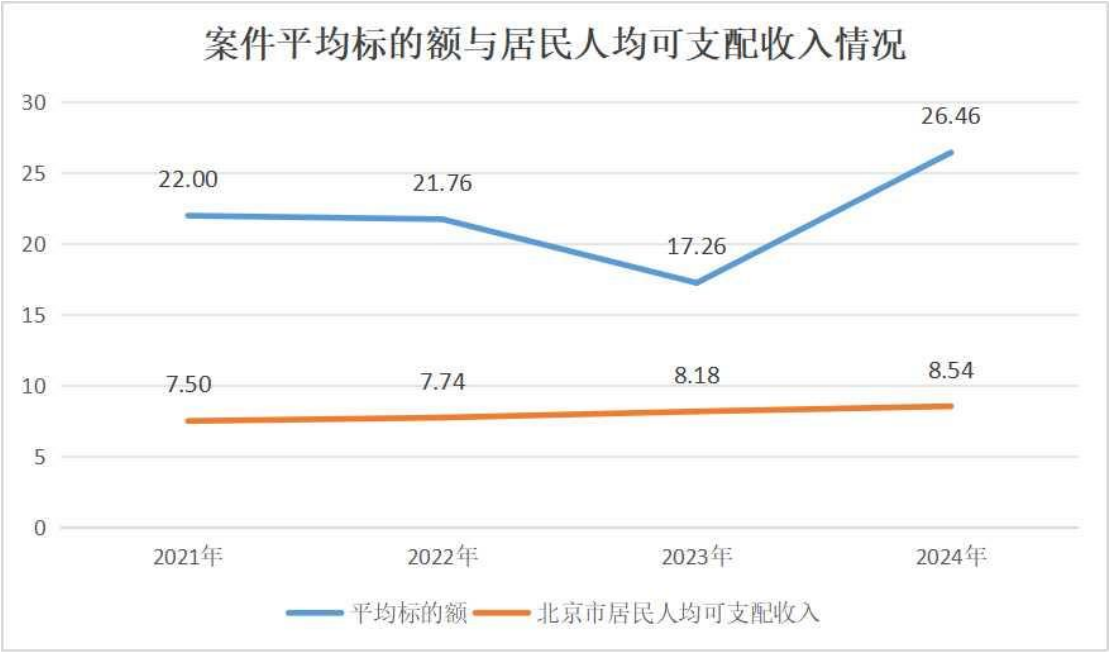


图 2 案件平均标的额与居民人均可支配收入情况

从结案方式来看，以判决方式结案的占比最高，为 40%，其次是调解结案的占比 29%，以按撤诉处理及准予撤诉方式结案的分别为 16%和 9%。从审判结果来看，支持及部分支持原告诉讼请求 71 件，判决驳回原告诉讼请求 41 件，调解 83 件，审判结果中支持被保险人诉讼请求的比例达到 78.97%，被保险人合理诉求获得司法支持的概率较高。从案件审理效率来看，简易程序占比显著上升，案件平均审理时长由 2021 年的 217 天下降为 2024 年的 82 天，重疾险案件平均审理时长大幅缩短。以上数据表明，重疾险案案件审理周期大幅压缩的同时调解率上升，体现了审判效率及效果的统一。（详见图 3-图 4）

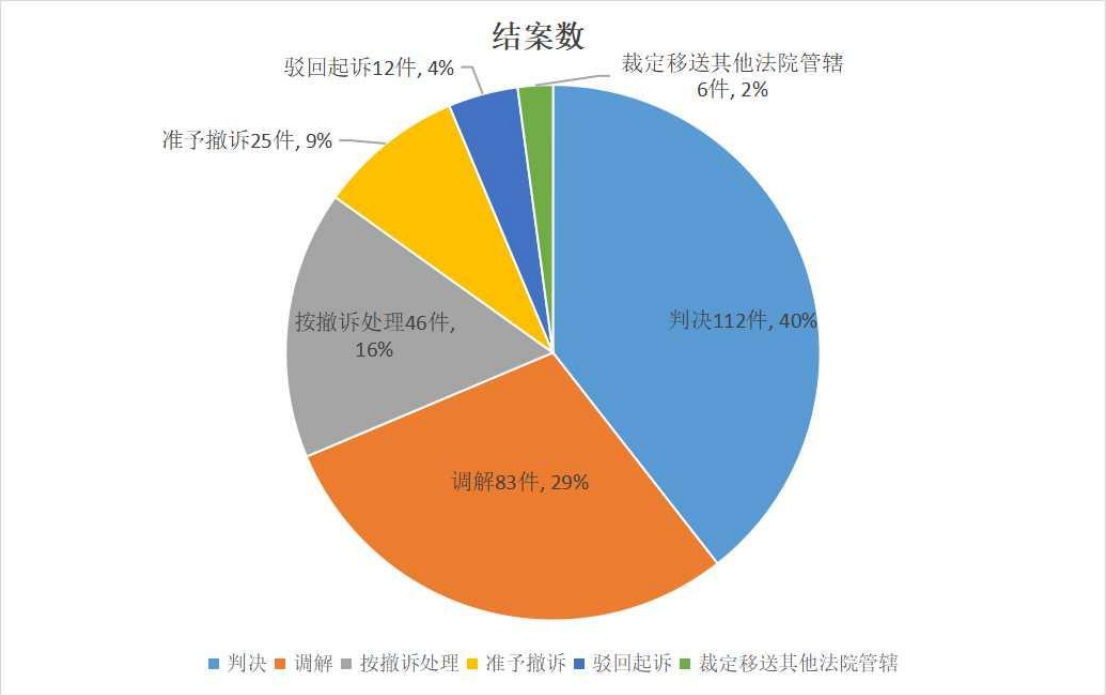
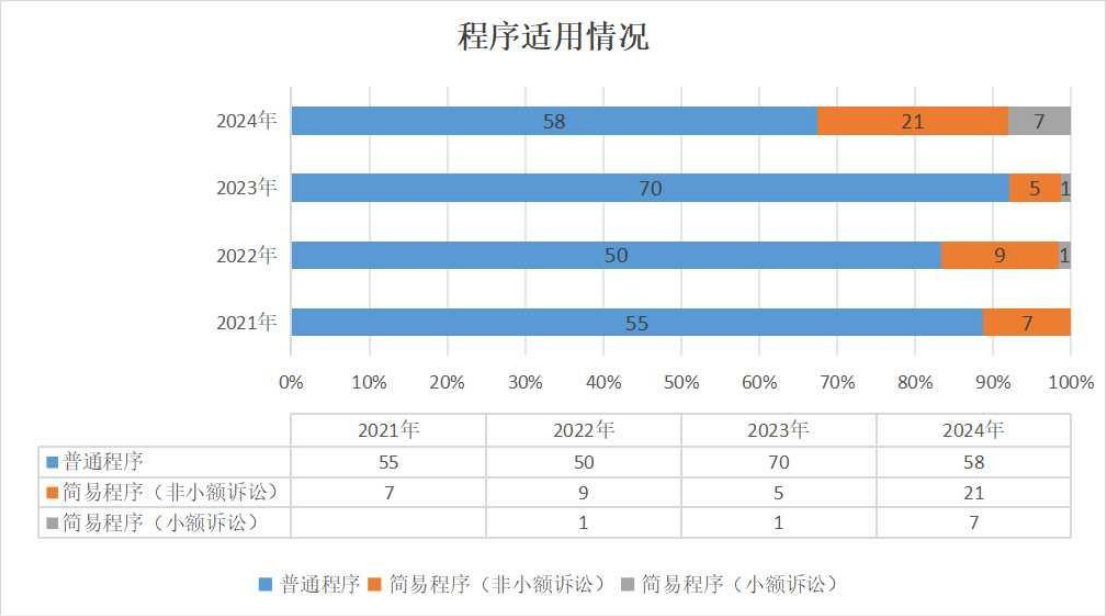


图 3 结案方式



	2021年	2022年	2023年	2024年
普通程序	55	50	70	58
简易程序（非小额诉讼）	7	9	5	21
简易程序（小额诉讼）		1	1	7

图 4 程序适用情况

从投保方式看，卷宗材料能够识别投保方式的案件共有 223 件，其中电子投保 158 件，纸质投保 65 件，当前重疾险投保以电子渠道为主导。

从所涉疾病看，恶性肿瘤案件数量较多，其中甲状腺恶性肿瘤 39 例，肺部恶性肿瘤 23 例，乳腺恶性肿瘤 17 例。其次为心脑血管类疾病，例如脑出血、脑溢血、脑梗死等脑部疾病 29 例，心脏部疾病 27 例。此外，还涉及肝豆状核变性、胶质母细胞瘤、小脑扁桃体下疝、克罗恩病等罕见病，公众认知度较低，具有较高的专业性和技术性，争议处理难度较高。（详见图 6）

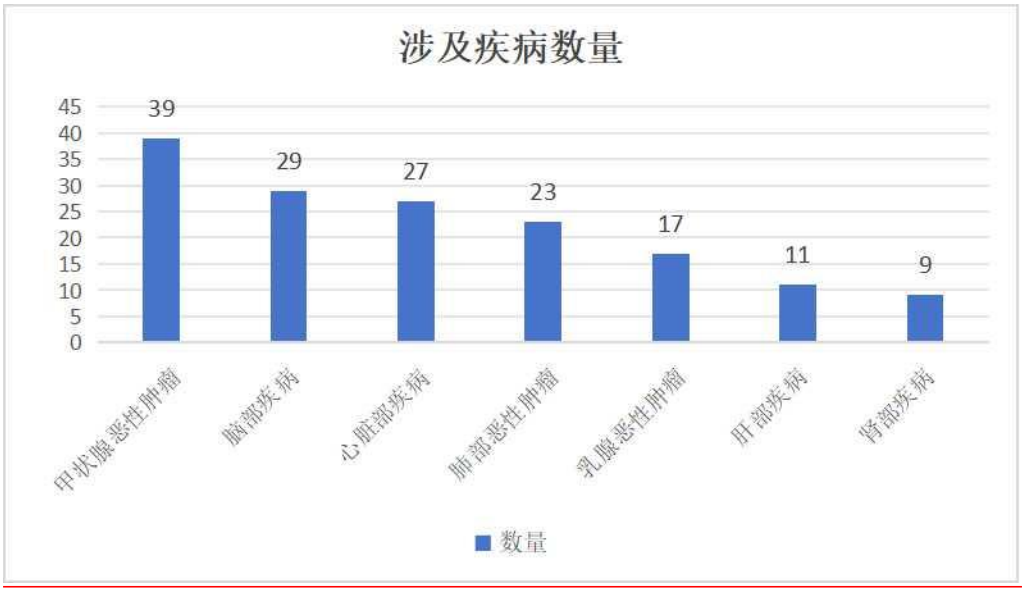


图 6 涉及疾病数量

从争议情况看，保险公司抗辩理由集中于以下方面：1. 投保人未履行如实告知义务（85 件）；2. 所患疾病为保险合同免责条款约定情形（36 件）；3. 被保险人所患疾病未达到保险合同约定的重大疾病严重程度（42 件）；4. 被保险人符合等待期内接受医学检查或治疗，且延续至等待期满后确诊的同一种疾病情形（12 件）；5. 已超诉讼时效（7 件）；6. 超两年不可抗辩条款的适用（2 件）。（详见图 7）

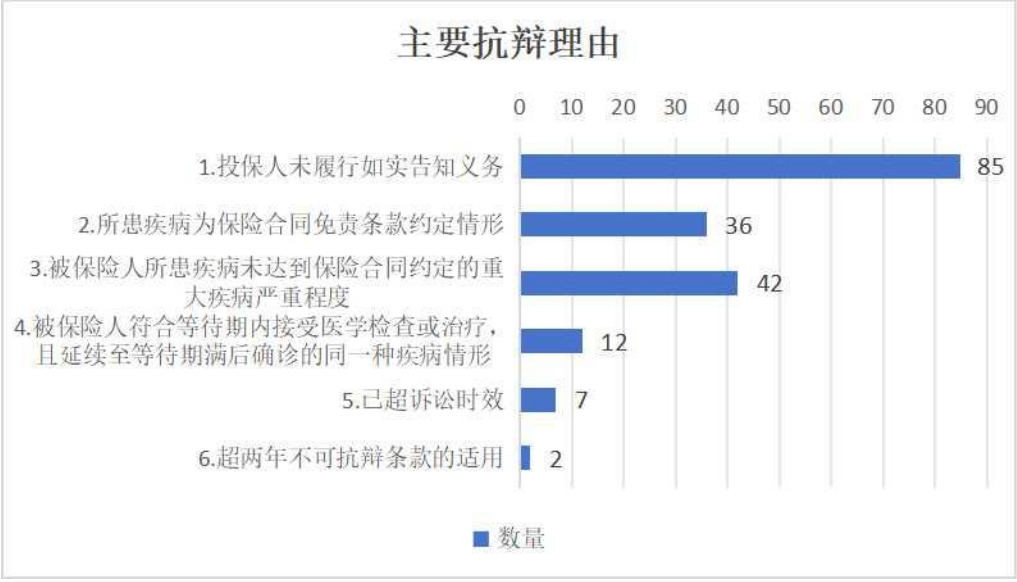


图 7 主要抗辩理由

二、涉重疾险纠纷案件特点

（一）重疾险具有高度专业性

重大疾病保险产品兼具高度的医学专业性与保险技术性，保险公司具有专业的医疗专业人才和精算人才，保险消费者处于相对信息弱势地位。

第一，重疾险理赔范围具有医学专业性。重疾险的功能在于向确诊特定重疾的被保险人支付保险金，为治疗疾病、恢复生活提供保障。**首先，重大疾病的判断具有医学专业性。**随着医学的发展，对特定疾病认识可能发生变化，将导致理赔范围发生变化。如在保险合同签订时，依据世界卫生组织《疾病和有关健康问题的国际统计分类》第十次修订（ICD-10），高级别鳞状上皮内病变 CIN2 级不属于原位癌，但依据目前通行适用的疾病分类标准《疾病和有关健康问题

的国际统计分类》第十一次修订版（ICD-11），高级别鳞状上皮内病变 CIN2 级属于原位癌等。**其次，对疾病严重程度的判断具有医学专业性。**如条款约定肝豆状核变性疾病理赔须同时满足出现角膜色素环（K-F 环）、血清铜和血清铜蓝蛋白降低，尿铜增加等全部典型症状。又如严重肌营养不良须同时满足肌肉组织活检结果显示肌营养不良症的肌肉细胞变性、坏死等阳性改变、自主生活能力严重丧失，无法独立完成六项基本日常生活活动中的三项或三项以上等。**第三，保险条款约定的疾病治疗方式具有医学专业性。**如胸主动脉夹层 B 型疾病理赔需满足经过主动脉手术，已经实施了开胸或开腹进行的切除、置换、修补病损主动脉血管、主动脉创伤后修复的手术等。

上述关于重疾险条款的内容是否合理，保险公司是否就条款向投保人进行提示说明是当事人争议比较集中的内容。

第二，重疾险的理赔具有保险技术性。重疾险产品设计背后涉及精密的数学逻辑与风险管理，一方面，为保证竞争力，重疾险的产品设计依赖于预定利率、费用率、疾病发生率等精算科学，因此倾向于细化限定理赔范围；另一方面，重疾险保险条款本身亦具有高度的法律专业性，法律主体包括投保人、被保险人和保险人，不同主体之间具有不同的权利义务。保险关系中的专业名词如“等待期”“如实告知”“不可抗辩条款”等，并非日常生活中常见的内容，普通投保人可能误解或忽略保险条款中的关键细节。在理赔时，保

险消费者往往不易理解未告知既往症、于等待期内患病、超两年不可抗辩条款等保险术语的确切内容，导致纠纷。

（二）电子投保成为主流

随着互联网保险业务蓬勃发展和消费者对保险认知的提升，操作便捷、流程简单的电子投保规模不断扩大，日趋成为主流投保方式。目前电子投保主要包含两种形式：一是投保人自主选择通过保险机构网络平台订立保险合同；二是保险业务员为投保人定制保险计划，并向投保人发送链接，由投保人通过点击链接进行操作，从而订立保险合同。相较于线下销售模式，电子投保具有保险产品获取渠道广、线上订立合同效率高、保单与合同随时可查等突出优势。

对于电子投保这一投保方式，原中国银行保险监督管理委员会于2020年12月7日发布《互联网保险业务监管办法》，对电子投保的业务条件、销售管理、服务管理、运营管理等方面进行全面规制。然而在审判实践中，我们注意到仍有部分保险业务未严格落实该监管办法，存在以下问题：一是未做到通过有效技术手段记录、保存互联网保险主要业务过程，在纠纷中无法提供案涉保险回溯视频，难以证明投保过程；二是投保人与被保险人并非同一主体时，对于健康告知等关系被保险人切身利益、决定保险人承保与否的关键信息并未详细与被保险人核实；三是线上投保存在被保险人电子签名由他人代签情形，保险公司难以提交证据证明电子签名真实性。在审判实践中，上述问题造成实际投保与用户需求不匹配，投保人诉请撤销、解除重疾险合同案件频发；投保人是

否履行如实告知义务难查清，围绕投保事实争议大；保险公司对于履行提示说明义务举证难，举证能力明显不足等情况多发。

（三）争议焦点集中

大多数重疾险拒赔案件中，保险公司拒赔理由相似，因此案件争议焦点相对集中。司法实践中，争议焦点主要集中在如下方面：一是健康询问环节：投保人未就保险人的概括询问进行回答，是否违反如实告知义务；投保人因重大过失未履行如实告知义务，未告知事项与保险事故并无因果关系的判断；投保人未回答保险人明确询问外的事项，是否违反如实告知义务。二是理赔环节：两年不可抗辩条款适用过程中，截止时间应为保险事故发生之日还是申请理赔之日；保险合同订立时不属于理赔范围的疾病，在订立后根据疾病分类最新标准属于重大疾病，是否能够获赔；重疾险对于疾病严重程度的二次限定条款效力及认定标准；疾病的特定诊断方式能否成为疾病严重程度的认定标准。三是免责条款效力的认定：电子投保情形下，保险人免责条款的提示说明义务如何认定；销售人员代操作投保能否视为履行了提示说明义务；重疾险等待期条款是否应以“疾病本质属性一致”作为认定标准等。因争议焦点相对集中，案件整体规律性亦较强，因此存在争议焦点整合、汇集裁判思路的必要性。

三、涉重疾险纠纷审判工作举措

民生无小事，枝叶总关情。张军院长强调，司法审判工

作，说到底是一项“守心”的工作，要以“如我在诉”的意识办好民生案。保险是普惠金融领域落实“以人民为中心”的“实验田”，西城法院严格落实习近平总书记重要指示和张军院长讲话精神，结合自身优势，抓牢审判管理指标，抓强专业能力建设，切实提升工作质效。

（一）抓牢审判管理指标，全面提升审判质量新效能

人民法院审判质量管理指标体系，目的是要引导法院做实“从政治上看、从法治上办”，立足“感受公平正义”的主体是人民群众，在全面提升审判质效和实质性化解矛盾上狠下功夫，用最优质量、最高效率、最佳效果处理好每一个案件。第一，依托审判辅助事务集约化改革，合理运用庭审排期、调查取证等集约事务专业化团队力量，不断完善全流程工作链条，实现司法资源配置优化，全面提升案件办理质效。第二，细化审判团队分工协作，向程序“要”效率。首先，针对争议集中、相对简单的案件，适用人身保险合同纠纷要素式起诉状、答辩状，以清晰的案件要素，绘就详细的“案件地图”，实现纠纷高效化解的同时提供类案参考。其次，针对案情复杂、争议突出案件，通过精细化管理事务性工作、完善庭前准备工作、高效庭审裁判加快案件办理节奏，尽量避免审理周期因追加当事人、变更诉讼请求、调取证据等延长。第三，加强审判数据分析，强化对涉重疾险审判态势的总体把控，及时发现涉重疾险纠纷案件审理工作中新类型、多发性、争议性问题。第四，做好释法说理、判后答疑工作，循循善诱讲明“事理”，义正言辞讲清“法理”，感

同身受讲透“情理”，提高息诉服判率，以类案裁判促进后续案件快速化解。通过这些工作举措，2024 年，金融街法庭在涉重疾险纠纷案件审理数量较 2021 年上涨 38.71%的情况下，平均审理周期反而缩短了 62.21%，审判效率提升明显。

（二）锻造高素质审判队伍，精准推进审判专业化建设

不断健全精审团队配置，通过搭建 6 个精审团队，对保险类案件进行专业化审理，完善专业法官会议机制与细则，对涉民生、新类型、典型性案件加强研究和案例培育。探究保险行业面临的类型化法律风险，以扎实的金融审判树立明确的裁判规则，体现维护金融市场秩序、保障金融安全的司法导向，促进保险业发挥其经济减震器和社会稳定器的作用。针对有典型性的类型化案件，开展示范庭审活动，发挥示范带动作用；邀请市、区人大代表，监管部门等单位代表参与典型案件旁听，聚焦社会影响，强化法治宣传效果，规范机构展业，稳定市场预期；聚焦人才培养，提升司法能力水平，注重实战实训，组织青年法官现场观摩、庭审评议。提倡法官助理主持庭前会议，处理程序问题，聚焦核心裁判，为高效审判夯实基础的同时，让法官助理打破身份框架，主动切换“法官视角”，快速带动法官助理队伍整体素质提升，为审判工作持续高质量发展积蓄坚实的人才力量。作为最高院民二庭、中国社科院法学研究所、中央财经大学法学院、国际关系学院、西南政法大学等单位的调研基地或教学实践基地，多次组织模拟法庭，实战演练，接待最高院机关党校基层调研活动，促进金融审判理论研究与司法实践的深度融合。

对特定案由所涉常见疑难问题，建立金融案件常用判点说理库，对常见争点的说理形成标准化成果，指导司法实践和审判工作。

（三）联动多部门调解，绘就多元解纷新“枫”景

针对保险理赔案件类型化突出的特点，西城法院构建多部门调解，强化府院联动，努力实现法律效果、政治效果、社会效果的有机统一。对于行业内的类型化问题或某一类产品的集中问题，及时与调解组织、监管部门沟通，形成社会治理合力。近年来，西城法院与北京市金融消费纠纷人民调解委员会、北京秉正银行业消费者权益保护促进中心、北京保险行业协会等单位建立多元解纷机制，与社科院法学所、国际法所、金融街服务局等单位建立司政产学研工作机制，将行政调解、行业调解、专业调解相结合，助力构建市场化、法治化营商环境，护航保险行业发展。

（四）诉前判后多措并举，营造良好金融法治环境

以“先锋同行”机制为引领，持续深化“引进来、走出去”，邀请人大代表参加法庭开放日活动，与街道社区、行业协会、监管部门开展金融问题调研座谈和普法宣讲，针对保险业常见法律问题制作并发放普法宣传手册，促进纠纷多元化解，共同护航保险行业发展。定期举办新闻通报会，每一期通报一类金融纠纷案件审理情况、案件特征及典型案例，为维护金融消费者合法权益、督促金融机构经营提供指引和帮助。通过重疾险理赔案件的个案宣传，提示保险领域应当顺应医疗技术发展，不断完善和调整保险格式条款，充分保

障保险消费者合法权益，规范保险行业发展。建立健全司法建议“制发—整改—反馈”机制。针对个案、类案审判工作中反映的综合治理问题、深层次问题开展调研，精准把握问题焦点，深入分析问题成因，向保险公司及相关部门提出高质量司法建议，及时回访落实情况，确保建议取得实效。

四、涉重疾险业务对策建议

为进一步保护消费者权益、充分发挥保险分摊风险、保障民生的作用，促进行业健康发展，保险公司、行业协会、司法机关、监管部门应形成治理合力，实现纠纷妥善化解。

（一）保险公司合规经营，发挥风险保障最大效能

保险公司应当建立健全覆盖组织体系、制度建设、运行机制、保障机制的合规管理体系，在保险合同签订、客户维护、保险义务的履行环节持续提质增效，切实扭转大众“投保易、理赔难”的印象。

第一，严格规范销售行为。销售服务是消费者了解保险产品的基础。通过案例可以发现，销售环节瑕疵是保险案件纠纷的重灾区。保险公司应细化销售环节管理规范，实施全流程闭环管理。落实《保险代理人监管规定》的要求，加强对保险代理人的业务培训、法律合规培训，并保留培训记录。细化保险代理人员管理规范，对销售行为进行标准化管理。加强对保险代理人的日常管理和检查，确保全流程可追溯，杜绝“阴阳合同”“飞单”、代持保单等违规行为。在销售过程中应向投保人明确告知保险“射幸合同”的特点，严格

禁止夸大宣传、欺诈销售等行为。做实做好“询问-告知”流程，避免投保前的询问流于形式，严禁保险代理人代为填写或诱导投保人虚假填写健康调查问卷。对于投保人与被保险人不一致的情况，为防止投保人故意或因重大过失不告知被保险人健康状况的风险，建议保险公司要求被保险人自行填写健康调查问卷或要求被保险人在投保材料上亲笔签字确认投保相关内容。对于以死亡为给付条件的保险，为保证保险合同的有效性，应当要求被保险人亲自确认同意投保。落实格式条款提示说明义务，保险条款作为保险公司提供的专业性条款，条款中对投保人、被保险人有重大影响的内容应当以投保人能够理解的方式进行详细的讲解，不能以投保人阅读条款代替保险人的提示说明，确保消费者在对产品责任、免责条款、退保损失、缴费期限等关键信息充分知情的基础上自主选择保险产品。

第二，提升理赔服务质量。理赔服务是消费者获得感的核心。保险公司应当不断优化保险理赔服务，实现从销售驱动、价格竞争向产品与服务驱动的战略转型。加大科技赋能，逐步提升理赔数字化、智能化水平，简化理赔流程，压缩理赔时效，推行“小额快赔”和“线上理赔”，提升服务质量。建立拒赔回溯管理，对于拒赔后当事人起诉被法院判决赔偿的案件应及时总结，弥补流程漏洞。对于类似的申请理赔事项应当主动进行赔偿，不应就同类事项重复拒赔。畅通投诉渠道及纠纷化解途径，践行“最大诚信原则”，完善内部理赔复核与纠纷调解机制，给予客户合理的内部申诉渠道，将

消费者权益保护工作纳入公司治理、企业文化和经营发展战略，争取在诉前通过内部沟通及行业调解高效化解争议，尽量做到纠纷不出行业。

第三，提升诉讼应对能力和水平。建立健全应诉机制和合规自查机制。对被保险人提起诉讼的案件，可以结合已经收到的原告起诉材料以及既有判例，对理赔纠纷案件进行自查，对已有类案判决的纠纷采取庭外和解、行业调解等更高效、便捷的纠纷化解方式，避免不必要的诉讼流程，浪费司法资源。经自查后确实无法理赔的案件，应当一次性提交全部证据材料并编制证据目录，写明证明目的，避免多次提交证据影响诉讼效率。根据《互联网保险业务监管办法》第三十三条的规定：保险机构应采用有效技术手段对投保人身份信息的真实性进行验证，应完整记录和保存互联网保险主要业务过程，包括：产品销售页面的内容信息、投保人操作轨迹、保全理赔及投诉服务记录等，做到销售和服务等主要行为信息不可篡改并全流程可回溯。保险公司应对互联网销售，包括互联网平台投保以及向投保人发送投保链接自行投保等业务模式全流程进行证据保存，避免因证据保存不完整而承担举证不能的不利后果。加强诉讼代理人培训，规范代理人在诉讼过程中的态度言辞，避免激化矛盾。

（二）行业协会自律管理，激发合规展业内生动力

保险行业协会是保险业自律管理的重要组织，发挥着行业自律、协同监管、保护消费者权益的桥梁和纽带作用。

第一，牵头更新示范条款，规范业务发展。建议协会及时牵头更新保险示范条款，统一规范疾病的定义、诊断标准以及严重程度的判断标准等，对于条款中不必要的疾病确诊方式进行涤除，最大限度减少因定义语义理解偏差导致的理赔纠纷。对于符合社会公众一般认知的严重疾病或医学上目前无法治愈的疾病（如肝豆状核变性、杜式重症肌无力等）进行调研，是否有必要进行疾病严重程度的二次限定，或如何更科学地进行疾病严重程度的限定，从源头上保障条款的清晰与公平。对随着医学发展，能够进行明确分类的重大疾病，应及时更新条款，明确是否属于承保范围。若某一诊断方式或某一确定疾病严重程度的条件确属必要，则格式条款中应对于上述内容进行特别提示，避免因相关条款未向投保人提示说明而不成为合同内容。

第二，充分发挥行业自律惩戒职能。行业自律监管是金融治理体系的重要组成部分，在促进机构合规经营、从业人员合法展业、金融市场健康发展方面具有重要作用。协会应充分发挥行业自律职能，对违规展业的公司及时进行行业通报及惩戒；建立并完善保险代理人员诚信档案，对于查实存在严重销售误导、欺诈等违规行为的从业人员在行业内进行信息共享，提高违规成本，推动行业人员素质整体提升。通过行业自律规则促进成员公司通过优质服务进行良性竞争，提升行业整体声誉。

第三，做好消费者的沟通宣传工作。畅通消费者与行业的沟通渠道，多维度化解纠纷。通过多种方式普及重疾险基

本知识，解读监管政策与典型案例，提升公众对保险业务的理解。丰富媒体宣传渠道，讲好保险故事，增强宣传温度，提升公众触达与信任度，促进行业整体发展。

（三）消费者提高法律意识，依法维护自身合法权益

第一，了解保险“射幸合同”的法律性质。所谓“射幸合同”是指当事人之间签订的包含不确定给付内容的风险性协议。给付内容取决于合同约定的偶然事件是否发生。在保险合同领域该偶然事件即是保险合同约定的保险事故。商业保险是平等主体之间订立的合同，只有符合合同约定的条件，保险公司才履行给付义务。被保险人在申请理赔时，应当按照保险合同的约定提交理赔资料原件，必要时需配合保险公司进行事故调查。

第二，遵循最大诚信原则依法订立合同。最大诚信原则旨在平衡保险双方利益，保证市场的公平性和稳定性。投保时，投保人应当依据《保险法》第十六条的规定履行如实告知义务。对于保险公司健康调查问卷中明确询问的事项应当如实告知，对于投保人及被保险人不一致的情况，投保人应当将问卷内容全面询问被保险人，避免因未如实告知影响理赔。

第三，认真阅读保险条款、了解保障范围。仔细阅读保险条款，对条款中不理解的内容要及时向保险人进行询问，应当特别关注保险范围、保费缴纳、责任免除条款等内容，不同的重疾险条款在保障范围、理赔金额和既往症理赔限制等方面有所不同，应在明确条款内容的基础上选择合适的产

品进行投保。关注回访电话的内容，对回访电话中的问题如实回答，对于回访电话中不清楚的内容，应当及时要求保险人进行进一步说明，避免简单回答“是”“清楚”，相关回访内容将作为保险人已经履行提示说明义务的依据。

第四，从正规渠道购买保险。保险系经国家行业主管部门审批获得许可后方能开展的业务。未经审批，非保险公司不得开展保险业务。消费者在购买保险时应从正规渠道购买，对于公司及人员资质、保单真实性应进行必要的确认。保险公司不得销售营业范围外的其他投资、理财产品，保险业务人员同时推销其他产品的，应当拨打保险公司官方客服电话进行核实，并注意产品的相对方主体信息。

第五，提升依法维权能力。一是提高法律意识。了解《保险法》中如格式条款、如实告知、保险利益等基本法律概念；了解投保人、保险人、被保险人等主体的法律地位及基本权利义务。二是提高诉讼维权意识。发生纠纷后，注意保存相关证据，如保单、保险合同条款、理赔材料、拒赔通知等，必要时通过诉讼维护自身合法权益。

（四）监管司法联动作为，发挥行业治理最强合力

第一，进一步加强与监管部门的沟通协作，助力监管“长牙带刺”，构建社会治理共同体。实现信息共享，定期将涉诉案件多、展业不规范的金融机构向监管部门通报，帮助监管部门从司法裁判中精准识别市场乱象根源。对经监管机关认定为瑕疵或违规的行为，要在民事判决的赔偿上有所体现，

实现行政处罚与民事赔偿多效并举，规范行业行为，保障消费者合法权益。

第二，在多元纠纷调解机制上深入合作。目前，北京市金融消费纠纷人民调解委员会已在西城法院金融街人民法庭挂牌设立常驻调解点，金融消费者和金融机构的纠纷可在该调解机构专业人员的调解下高效、快速地化解纠纷，消费者与金融机构达成协议的，可向法院申请司法确认，赋予该调解协议强制执行效力。法院将进一步加强对调解员的专业指导，以示范案例促进调解率稳步提升。

我们希望，通过保险公司完善服务流程、行业协会加强指导示范、监管机关实施长效监督、司法机关进行多元解纷，形成行业良性发展闭环，充分发挥重疾险业务对冲风险、保障人民群众基本生存需要的作用，维护市场公平秩序，最终实现行业高质量发展与消费者利益保护的有机统一。

五、典型案例

【案例一】健康询问时保险人概括性询问的效力

——秦某诉某保险公司人身保险合同纠纷案

【裁判观点】

在重疾险投保过程中，保险人就既往症情况等问题询问投保人时，所提出的问题必须具体、明确，避免使用概括性、模糊性的表述。若保险人使用“其他上述未提及的疾病”“是否存在其他不适”等过于笼统的询问方式，则变相加重了投保人的告知义务负担，保险人以此主张投保人未如实告知的，

法院不予支持。

【基本案情】

2019 年 11 月 19 日，秦某通过线上方式投保某保险公司重疾险。

保险合同第十七条约定，我们就您和被保险人的有关情况提出询问，您应当如实告知。如果您故意或者因重大过失未履行前款规定的如实告知义务，足以影响我们决定是否同意承保或者提高保险费率的，我们有权解除本合同。如果您故意不履行如实告知义务，对于本合同解除前发生的保险事故，我们不承担给付保险金的责任并不退还保险费。如果您因重大过失未履行如实告知义务，对保险事故的发生有严重影响的，对于本合同解除前发生的保险事故我们不承担给付保险金的责任，但应当无息退还您已缴纳的保险费。

投保时，秦某需回答某保险公司的健康询问，其中有询问内容为：“被保险人是否近一年有新发或以往既有以下症状？反复头痛或眩晕、晕厥、咯血、胸痛、原因不明发热.....原因不明的包块、结节或肿物、身体的其他感觉异常或活动障碍”，秦某回答否。在投保单中，有投保人的声明及确认：“我了解某保险公司将根据投保单的内容对我的投保申请进行核保，我声明对投保单中各项信息的填写和各种问题的回答及告知、申报事项均正确、真实”。

秦某于 2021 年 6 月被诊断为左侧三叉神经痛并住院手术治疗。某保险公司认可秦某的疾病属于保险条款中约定的

重大疾病。

某保险公司主张秦某未履行如实告知义务，未如实回答其询问的是否存在“身体的其他感觉异常或活动障碍”。经查，秦某于2018年9月19日的诊断结果为“左侧三叉神经痛？”，2018年10月31日门诊诊断为“左侧面颊疼痛：三叉神经痛？”，2018年11月13日，诊断为左颌面颊疼痛待诊。

秦某于2021年6月17日向某保险公司申请理赔，某保险公司作出《理赔决定通知书》，上载：由于在投保时未如实告知被保险人已存在的疾病/症状，影响了我公司的承保结论，我公司不承担本保险合同的保险责任。故秦某诉至法院，要求给付保险金。

【裁判结果】

某保险公司的询问系概括性条款。《保险法司法解释二》第六条规定，投保人的告知义务限于保险人询问的范围和内容。当事人对询问范围及内容有争议的，保险人负举证责任。保险人以投保人违反了对投保单询问表中所列概括性条款的如实告知义务为由请求解除合同的，人民法院不予支持。所谓概括性条款，是指缺乏具体内涵、外延难以界定的条款。实践中，概括性条款一般是以“其他”“除此以外”等兜底条款的方式出现。本案中，某保险公司在“反复头痛或眩晕、晕厥、咯血、胸痛”等具体症状之后所列“身体的其他感觉异常或活动障碍”，该内容是对上述病症之外的兜底性条款，未列明异常的部位，缺乏具体内容，属于概括性条款。对于

这种询问，投保人无法做到真正如实告知。故该概括性条款不能视为保险人的明确询问，保险人不能以投保人对该问题没有如实回答解除合同。秦某投保前虽存在面部疼痛，但并非已被诊断为三叉神经痛。其作为普通保险消费者，无法知晓医院未确诊的面部疼痛属于应当告知的“身体的其他感觉异常或活动障碍”，故不能认定秦某违反如实告知义务。某保险公司无权解除保险合同，应向秦某支付保险赔偿金。

【典型意义】

投保人的如实告知义务应秉承询问告知模式，即投保人仅在保险人询问的范围内承担告知义务。对于保险人未询问的事项，即使其为重要事实，投保人亦无主动告知的责任。在询问告知模式下，保险人的询问是投保人告知义务的前提，投保人对概括性询问未作回答时，不构成违反如实告知义务。这要求保险公司进一步优化询问设计，问题应具体、清晰、无歧义，避免因询问事项不够具体明确而在理赔过程中引发争议。

【案例二】投保人未如实告知与保险事故的因果关系认定

——冷某诉某保险公司人身保险合同纠纷案

【裁判观点】

投保人因重大过失未履行如实告知义务，未告知事项与保险事故发生没有关联性时，保险人可以解除合同，但应当进行赔付。

【基本案情】

2022 年 4 月 10 日，冷某投保某保险公司重疾险，保险期间一年。

保险条款第 6.1 条明确约定了如实告知义务。第 7.15 条重度疾病释义约定，（48）急性坏死性胰腺炎开腹手术指专科医生确诊为急性坏死性胰腺炎，并已经接受了开腹手术进行坏死组织清除、病灶切除或胰腺部分切除的治疗。因酗酒或饮酒过量所致的急性坏死性胰腺炎以及腹腔手术不在保障范围内。

2023 年 3 月 24 日，冷某被确诊为急性胰腺炎。

2023 年 4 月 4 日，冷某向某保险公司申请保险理赔，某保险公司拒赔。

某保险公司提交冷某投保时的回溯视频，投保页面显示点击我要投保，进入健康告知页面，最上方显示：请确认被保人的健康状况是否存在下列问题，请如实告知，否则将影响理赔。2.被保人目前或曾经患有下列疾病或疾病，肝病：肝炎（含肝炎病毒携带）、肝硬化。投保人进行浏览后点击下方确认无以上问题，弹出窗口提示：请完整阅读健康告知，确认被保人无其中所述问题，否则将影响理赔。投保人点击确认无问题，下方显示阅读并同意付款授权、投保须知、保险条款、服务协议、延续保障服务协议、客户告知书、健康服务协议，投保人点击同意协议并投保。

某保险公司提交 2018 年 6 月 29 日冷某入院记录，其中既往史记载患有脂肪肝、乙肝小三阳 10 年。某保险公司提

交冷某2020年10月10日免疫检验报告单，显示乙肝表面抗原阳性。保险公司以冷某未如实告知已确诊疾病为由拒赔。故冷某诉至法院，要求给付保险金。

【裁判结果】

关于投保人是否尽到保险合同项下的如实告知义务。根据投保回溯视频，投保过程中，某保险公司的健康询问内容包括是否被保险人目前或曾经患有肝病、肝炎（含肝炎病毒携带）、肝硬化，投保人在健康告知页面浏览后点击“确认无以上问题”。2018年6月29日冷某的入院记录既往史记载乙肝小三阳10年，2020年10月10日的免疫检验报告单中显示乙肝表面抗原阳性。冷某作为投保人与某保险公司签订保险合同时，应当将其患有乙肝小三阳的情况如实告知保险人，但冷某并未尽到如实告知义务。某保险公司的询问明确、具体，且冷某在尽到一般人的注意义务后即能够对该询问作出正确理解，其未如实回答存在重大过失。

关于某保险公司是否应支付保险金，冷某确诊的急性重症胰腺炎属于案涉重疾险合同中约定的保险事故。按照《保险法》第十六条规定：“投保人故意或者因重大过失未履行前款规定的如实告知义务，足以影响保险人决定是否同意承保或者提高保险费率的，保险人有权解除合同”。本案中，某保险公司并未举证证明冷某未告知的其患有乙肝小三阳与最终确诊的急性重症胰腺炎之间存在因果关系，故某保险公司可以解除保险合同，但应当支付保险金。

【典型意义】

在重疾险投保过程中，投保人常因身体状况异常距投保时间久远、投保人缺乏保险经验、对未告知事项的关注程度不足等原因，因过失未能履行如实告知义务，此时将审查未如实告知事项与保险事故间的因果关系，以及未如实告知事项对保险理赔的影响。投保人在投保过程中应秉持最大诚信原则，认真阅读询问内容后如实填写，从源头消除争议。

【案例三】投保人询问的涵义应当严格按照文义解释确定

——蔡某诉某保险公司人身保险合同纠纷案

【裁判观点】

投保人如实告知的范围仅限于保险人的明确询问，在对询问内容进行解释时，应采用严格的文义解释，保险公司主张对询问问题扩大解释或类推适用的，人民法院不予支持。

【基本案情】

2021 年 11 月 19 日，蔡某投保重疾保险，保险金额为 35 万元。投保人需在电子投保单填写健康信息告知，其中询问内容包括：“19.您是否曾经患有或被告知患有下列症状或疾病？……女性适用：乳房、卵巢、子宫疾病或其他妇产科疾病？”蔡某均勾选“否”。

保险合同条款约定：2.4.1.1 轻症重疾保险金：被保险人在确诊首次患本合同约定的重大疾病（无论一种或多种）前，经本公司认可的医院专科医生确诊首次患本合同约定的轻症重疾，本公司按照被保险人确诊时本合同基本保险金额

的30%给付轻症重疾保险金。

2022年9月，蔡某被诊断为子宫颈原位癌，属于保险合同约定的轻症重疾保险范围。另查，蔡某2021年9月体检报告显示HPV18阳性高危型HPV感染。TCT检测提示：无上皮内病变或恶性病变。

保险公司认为蔡某于2021年9月检查出HPV18阳性高危型HPV感染，属于“子宫疾病或其他妇产科疾病”，蔡某并未将上述情况如实告知，故不同意理赔。蔡某诉至法院要求给付保险金。

【裁判结果】

《保险法司法解释二》第六条规定：“投保人的告知义务限于保险人询问的范围和内容。当事人对询问范围及内容有争议的，保险人负举证责任”。对保险人的询问，应当严格按照文义解释确定投保人询问的涵义，保险人对询问内容进行扩大理解的，法院不予支持。本案中投保单健康询问第19项：“您是否曾经患有或被告知患有乳房卵巢子宫疾病或其他妇产科疾病”，并未明确询问是否感染HPV病毒。感染HPV病毒只是引发疾病的一种可能性，感染病毒不等同于患有妇产科疾病，且蔡某2021年体检报告亦显示TCT结果正常，根据上述体检报告，尚不足以得出蔡某已经患有妇产科疾病的结论，故某保险公司主张蔡某违反如实告知义务，依据不足，法院不予采纳，故支持了原告的诉讼请求。

【典型意义】

相较于投保人，保险人在医学专业知识、信息的获取与

处理能力上具有明显优势，为平衡双方权利义务关系，我国保险法对投保人的如实告知义务采取“询问-告知主义”的立法模式。在该模式下，义务人仅就保险人询问的内容承担告知义务，故对于哪些内容属于必须告知的重要事实，保险人应当妥善设置询问问题，进行明确询问。实践中有些保险公司在理赔核保时，对询问问题进行扩大解释或类推适用，进而认定投保人未如实告知，有违《保险法》的相关规定及立法精神。如经合理精算，相关疾病或异常情况对是否承保或提高保费确有影响的，保险公司应当及时更新健康询问内容，进行语义明确的询问，避免类似纠纷。

【案例四】两年不可抗辩条款的适用

——王某诉某保险公司人身保险合同纠纷案

【裁判观点】

投保人故意或重大过失未履行如实告知义务，可能影响保险人是否同意承保或提高保险费率，保险人有权解除合同。保险合同订立满两年，保险人不能解除合同。该两年起算时间为保险合同成立之日，截止时间为保险事故发生之日而非申请理赔之日。

【基本案情】

2016 年 3 月 14 日，王某作为投保人与某保险公司签订案涉重疾险，被保险人为杜某，此后王某每年按期交保费。

案涉保险条款 8.1 条明确说明与如实告知约定：“……我们就您和被保险人的有关情况提出询问，您应当如实告知，

如果您故意或者因重大过失未履行前款规定的如实告知义务，足以影响我们决定是否同意承保或者提高保险费率的，我们有权解除本主险合同。如果您故意不履行如实告知义务，对于本主险合同解除前发生的保险事故，我们不承担给付保险金的责任，并不退还保费”。8.2 条本公司合同解除权的限制规定，“前条规定的合同解除权、自我们知道有解除事由之日起超过 30 日不行使而消灭，自本主险合同成立之日起超过两年的，我们不得解除合同，发生保险事故的，我们承担给付保险金的责任”。案涉保险合同重大疾病释义将“重大器官移植术或造血干细胞移植术”和“终末期肾病（或称慢性肾功能衰竭尿毒症期）”归于第 3 类重大疾病，前者定义为“因相应器官功能衰竭，已经实施了肾脏……的异体移植手术”，后者定义为“双肾功能慢性不可逆性衰竭，达到尿毒症期，经诊断后已经进行了至少 90 日的规律性透析治疗或实施了肾脏移植手术”。

王某提交的人身保险投保书显示：询问事项中，某保险公司询问：08、您是否目前患有或过去曾经患有下列疾病或手术史：……E 泌尿系统疾病，例如血尿、蛋白尿、尿路畸形、肾炎、肾病、肾脏功能不全、尿毒症、肾移植肾、肾积水、肾囊肿、泌尿系结石、泌尿系统手术史？投保人均选择“否”。

王某提交的电子投保申请确认书中有手写内容“本人已阅读保险条款、产品说明书和投保提示书，了解本产品的特点和保单利益的不确定性。”王某与杜某分别在投保人、被

保险人处签名。

2017 年 5 月被保险人杜某被诊断患有慢性肾病 5 期，2020 年 7 月，杜某接受肾移植手术。

2020 年 9 月 21 日，杜某向保险公司申请理赔，2020 年 9 月 27 日，某保险公司就保险事故向杜某进行询问，发现杜某于 2015 年时体检发现肌酐升高，并于 2015 年 11 月进行肾脏穿刺检查，提示间质性肾小管病变。关于投保经历，杜某自述在投保时未告知业务员体检肌酐异常。

2020 年 10 月 19 日，某保险公司作出书面拒赔通知，后王某诉至法院，要求给付保险金。

【裁判结果】

关于投保人是否尽到保险合同项下的如实告知义务。某保险公司在《人身保险投保书》中健康告知事项部分询问：“您是否目前患有或过去曾经患有下列疾病或手术史：……E 泌尿系统疾病，例如……肾炎、肾病、肾脏功能不全、尿毒症、肾移植肾、肾积水、肾囊肿、泌尿系结石、泌尿系统手术史？”，王某选择“否”。但杜某在 2015 年体检时发现肌酐升高，在 2015 年 11 月进行肾穿刺活检，病理诊断为亚急性肾小管间质肾病。某保险公司的询问明确具体，且投保人王某明知被保险人杜某罹患亚急性肾小管间质肾病，其未如实回答存在故意。

关于某保险公司解除合同是否超过两年期限。杜某于 2017 年 5 月已被确认为慢性肾病 5 期，属于保险合同中约定的“终末期肾病”，故在保险合同成立后 2 年内已发生保险

事故。故本案不属于合同订立两年后才发生保险事故的情形。

某保险公司于2020年9月21日收到理赔材料，并于10月19日出具了书面的理赔通知，亦未超出30日行使解除权，故法院判决驳回原告的诉讼请求。

【典型意义】

本案明确了不可抗辩条款中两年期间的起始时间。从如实告知制度设计的初衷看，投保人的如实告知义务是最大诚信原则的体现，被保险人自身的身体状况只有投保人最清楚，一旦隐瞒或欺骗，容易造成投保人与保险公司权利义务的失衡。同时，为防止保险人滥用解除权，《保险法》引入不可抗辩条款，即保险合同成立后超出两年，保险人不得以投保人未如实告知为由解除合同。如果将该两年的截止日期界定为申请理赔之日，则这一期限完全由申请理赔主体掌握，在不诚信投保已发生的情况下，将可能引发拖延理赔的道德风险。本案明确了两年截止时间为保险事故发生之日，符合最大诚信原则。

【案例五】保险理赔应符合疾病诊断的最新发展

——李某诉某保险公司人身保险合同纠纷案

【裁判观点】

保险公司理赔的疾病范围，应当符合疾病分类的最新标准。保险合同生效后，根据通行的医学诊断标准，被保险人所患疾病属于保险合同约定的赔付疾病范围已成医学共识的，保险公司应当承担保险责任。

【基本案情】

2019 年 7 月 26 日，李某投保重疾险，保险金额 30 万元。2022 年 5 月，李某被确诊为神经内分泌肿瘤（T1NOMO，I 期 G1），李某认为该疾病属于保险合同约定的恶性肿瘤重大疾病，故要求某保险公司支付保险金 30 万元。某保险公司认为根据保险合同约定的重大疾病确认标准世界卫生组织《疾病和有关健康问题的国际统计分类》（ICD-10）的规定，李某所患神经内分泌肿瘤属于交界性肿瘤，不属于恶性肿瘤，故不属于保险范围，不同意给付保险金。

根据世界卫生组织 2019 年发布的 WHO（2019）消化系统肿瘤分类,该分类显示神经内分泌肿瘤 G1 疾病代码为 8240/3，其中 3 代表恶性。

【裁判结果】

本案的争议焦点为李某所患神经内分泌肿瘤是否达到保险合同约定的重大疾病恶性肿瘤的赔付条件。

法院审查认为，根据世界卫生组织最新的 WHO（2019）消化系统肿瘤分类，结合《中国抗癌协会神经内分泌肿瘤诊治指南 2022 年版》的记载及权威医院的科普文章，神经内分泌肿瘤 G1 属于恶性肿瘤。因神经内分泌肿瘤的临床表现异质性的特点，最初作为疑难杂症或“类癌”病症处理，随着医学研究对此类病症的深入认识，神经内分泌肿瘤作为恶性肿瘤已经成为医学共识。李某超声胃镜检查提示为：“符合胃神经内分泌瘤改变，累及黏膜层至粘膜下层”。可见李某所患疾病具有浸润和破坏周围正常组织的特点，属于恶性

肿瘤。

人类对疾病的研究和认识不断向前发展，从前不明原因的症状将逐渐获得明确的认知及定性，保险合同的保障范围亦应当符合疾病认知的发展。世界卫生组织已经在“WHO（2019）消化系统肿瘤分类”中将神经内分泌肿瘤确认为恶性肿瘤，该项分类标准亦属世界卫生组织的权威标准，且被我国医学借鉴和采用，保险公司理赔的疾病范围，应当符合疾病分类的最新标准。

综上，法院判决某保险公司向李某支付保险金。

【典型意义】

重疾险的理赔范围应当随着医学进步而发展，在对疾病进行判断时，需要依据最新医学诊断标准。目前，重疾险的保险条款通常约定疾病分类按照世界卫生组织于 1994 年发布的 ICD-10 进行确定。世界卫生组织于 2019 年发布了修订版本 ICD-11，该版本又陆续进行了更新，目前最新版本为 2025 年 2 月版本。在此情况下，保险合同约定的承保范围及疾病判断标准也应当符合医学发展和最新的权威分类标准，符合普通民众的通常理解以及被保险人的合理期待。在保险条款没有及时更新的情况下，法院将按照最新标准确定被保险人所患疾病是否属于保险合同承保的重大疾病，切实保障罹患疾病的被保险人的合法权益。

【案例六】以特定病症作为严重程度的限定条件效力及认定标准

——李某诉某保险公司人身保险合同纠纷案

【裁判观点】

保险条款对重大疾病严重程度约定不合常理、不符合客观生活实际的限定条件，属保险公司应当明确提示说明的格式条款。保险公司未尽提示说明义务的，该条款对被保险人不发生效力。

【基本案情】

李某出生于2002年2月18日。2019年4月20日，李某之父以李某为被保险人向某保险公司投保某重疾险，保险期间终身，交费年限20年，基本保险金额401 000元。

案涉重疾险条款载明：1.被保险人经医院确诊初次发生本附加险合同约定的“重大疾病”，保险公司按照本附加险合同基本保险金额给付重大疾病保险金。3.保险公司提供保障的重大疾病共有100种，具体见重大疾病释义……81.严重的Ⅰ型糖尿病:胰岛素分泌绝对不足引起的慢性血糖升高，且已经持续性地依赖外源性胰岛素维持180日以上。须经血胰岛素测定、血C肽测定或尿C肽测定，结果异常，由内分泌科专科医生明确诊断，并须在本附加险合同保险期间内，满足下列至少1个条件：（1）已出现增殖性视网膜病变；（2）须植入心脏起搏器治疗心脏病；（3）因坏疽需切除至少一个脚趾（该部分条件以下简称三项条件）。保险条款除严重Ⅰ型糖尿病几个字体加黑加粗外，关于严重Ⅰ型糖尿病的上述定义未加黑、加粗或以其他形式突出显示。

2023年11月18日至2023年12月4日，李某住院治疗，出院诊断病情为：暴发性Ⅰ型糖尿病、糖尿病酮症酸中毒等。后多次因糖尿病性酮症、暴发性Ⅰ型糖尿病入院治疗且下发《病危病重通知书》。

李某向法院提起诉讼，要求某保险公司向李某给付重大疾病保险金40万元、重大疾病陪护保险金6万元。

【裁判结果】

本案争议焦点为案涉附加重疾险中关于严重Ⅰ型糖尿病定义条款的性质。首先，案涉保险条款对Ⅰ型糖尿病的严重程度限定了多个条件，属于某保险公司在无权威医学标准前提下自行制定的对投保人、被保险人有重大利害关系的条款，某保险公司对该部分条款应依法履行提示和明确说明义务。对于严重程度限定必须出现特定的病症，须举证证明已就此向投保人进行了详细、具体的说明，现某保险公司未尽提示说明义务。其次，李某的病情除已由专业医疗机构确诊为暴发性Ⅰ型糖尿病外，还存在病情危重被下发《病危病重通知书》、糖尿病性酮症酸中毒、糖尿病性酮症等情形，从一般人的认知看，已达到严重程度。因此，法院判决某保险公司按照保险合同约定向李某支付重大疾病保险金。

【典型意义】

实践中不同保险公司的多个重疾险保险条款都对重大疾病的严重程度以特定病症设定了多项条件。针对符合大众对重大疾病认知的相关疾病，上述约定属于对赔付条件成就的再次限缩，被保险人理赔范围变窄。根据《保险法》第十

七条、《保险法司法解释二》第九条的规定，保险公司应当在投保时对此类限定进行明确的提示说明，否则对赔付条件进行二次限定的免责条款不应对被保险人产生效力。

【案例七】疾病的特定诊断方式能否作为疾病严重程度的认定标准

——贾某诉某保险公司人身保险合同纠纷案

【裁判观点】

重大疾病保险条款中，疾病定义应为对疾病特征及严重程度的客观描述，疾病的诊断方式不应作为疾病严重程度的认定标准。

【基本案情】

贾某之母汪某为4岁的贾某在某保险公司投保案涉重大疾病保险。案涉保险单载明，重大疾病保险金额为100 000元。保险条款载明，重大疾病定义包括严重肝豆状核变性，但须同时满足四项条件，其中包括角膜色素环（K-F环）及经皮做肝脏活检来定量分析肝脏铜的含量。2023年7月，4岁的贾某被确诊肝豆状核变性。贾某申请理赔，某保险公司拒赔称，贾某未出现角膜色素环（K-F环）、未经肝脏活检确诊，故未达到保险合同约定的严重程度。贾某提交的病历载明，患儿KF环阴性，但KF环并非衡量病情严重程度的指标；患儿未行肝活检，因肝活检为有创性检查，如非必需，并非一定需要做的检查；患儿经基因检测，结合肝功能等指标，诊断明确，故未行肝活检检查。根据《中华肝脏病杂志》

记载，肝豆状核变性患者临床表现多样，因受累器官和程度不同而异，主要表现为肝脏和/或神经系统受累，神经精神系统表现、眼部表现亦为其临床表现形式。当临床怀疑肝豆状核变性时，可进行肝脏病理检查。肝豆状核变性治疗原则是尽早治疗、个体化治疗和终生治疗，不经治疗可出现严重的肝脏或神经系统损害、病死率比一般人群高。

贾某向法院提起诉讼，要求某保险公司向贾某给付保险金 100 000 元及利息。

【裁判结果】

贾某所患疾病属于案涉保险合同约定的重大疾病保障范围。第一，保险条款对重大疾病的限定应当符合大众对重大疾病的理解。肝豆状核变性患者临床表现多样，该疾病不经治疗可能会出现严重的肝脏或神经系统损害，病死率也高于一般人群，说明它具有相当的危险性，已达到重大疾病的严重程度。第二，重大疾病定义列举某一病症为必要条件的二次限定属于免责条款。出现角膜色素环是该疾病的临床表现之一，此类列举条件属于保险条款在确诊疾病的基础上对赔付范围进行了再次限缩，被保险人理赔范围变窄，此类二次限定应属免责条款。保险公司未举证证明已尽提示说明义务，该条款不应对被保险人产生效力。第三，诊断方式不应作为重大疾病的严重程度的认定标准，且根据《健康保险管理办法》第二十三条的规定，对重大疾病的确诊方式的要求应当符合疾病诊断标准的最新情况。本案中，进行肝脏活检仅为确诊该疾病的方式之一，并非衡量疾病严重程度的指标，

保险合同将其限定为理赔条件明显不合理。贾某已经通过基因检测及肝功能等指标的无创、无痛的检查方式确诊患有该疾病，无需使用肝脏活检的有创伤方式进行确诊。因此，法院判决某保险公司向贾某给付保险金 100 000 元及利息损失。

【典型意义】

本案涉及的是以诊断方式作为严重程度认定标准的重疾险常见典型问题，实践中不同保险公司的多种重疾险保险条款中都涉及对疾病严重程度的限定条件，其中有很多条件都与诊断方式相关，比如本案中的肝脏活检，严重肌营养不良症的肌肉活检等。对重大疾病定义的限定应当是对疾病是否严重以及严重到何种程度，比如严重影响身体健康和生活水平等的标准性判断，而诊断标准应当符合同行的医学诊断标准即可，不应限定必须使用某一种诊断方式确诊。随着医学的进步，从更有效确诊或减轻患者创伤痛苦的角度出发，传统的诊断方式可能会被更为先进的诊断方式所替代，根据《健康保险管理办法》第二十三条第二款规定：“健康保险合同生效后，被保险人根据通行的医学诊断标准被确诊疾病的，保险公司不得以该诊断标准与保险合同约定不符为理由拒绝给付保险金。”同时，保险公司也应当跟上医学进步的步伐，及时更新保险条款，让保险条款更加适应社会生活。

【案例八】电子投保场景下保险人免责条款提示说明义务的认定标准

——黄某诉某保险公司健康保险合同纠纷案

【裁判观点】

通过网络订立的保险合同，保险人需以加黑加粗、强制阅读等明显形式对免除保险人责任的条款予以提示和明确说明。若在电子投保过程中未直接展示免责条款，或未以明显方式或强制阅读等形式达到提示投保人阅读的效果，则不能认定保险公司履行了提示和明确说明义务，免责条款对被保险人不发生效力，保险人不可依据免责条款拒绝赔偿。

【基本案情】

2020 年 5 月 5 日，黄某之父以黄某为被保险人在互联网平台投保个人医疗保险。

保险条款约定：2.6 责任免除：因下列情形之一引起的保险事故，本公司不承担给付保险金的责任：（2）被保险人患有遗传性疾病 7.15，先天性畸形、变形或染色体异常。

2020 年 8 月，黄某住院治疗，出院诊断载明：1.黏多糖贮积症？8.凝血因子 XI 减少症。2022 年 4 月 6 日至 2023 年 9 月 20 日，黄某陆续在医院进行治疗。

黄某诉请法院判令某保险公司向黄某给付保险金 89 万余元。某保险公司辩称，投保人带病投保，投保前后隐瞒黄某患有遗传性疾病“凝血因子 XI 减少症”“黏多糖贮积症 II 型”的事实。责任免除条款均作出突出显示和加粗，并指引到具体条款的遗传性疾病定义。

关于投保流程，某保险公司提交公证书，载明通过某平台进入投保页面，投保须知中罗列有免责条款，该公证书描述了如何进入投保须知，但无对应页面截图；健康询问未针

对凝血因子减少症或粘多糖贮积症进行询问。投保页面项下有四个页签，分别为“我要投保”“产品特色”“理赔说明”“投保提示”。产品特色与理赔说明中展示了产品的优势与理赔成功案例；投保提示包含3条内容，其中第1条为“本产品对部分情形下发生的保险事故，不承担给付保险金的责任，请仔细阅读《责任免除》条款”；第2条为关于投保险已罹患疾病不予赔付的条款。第1条中《责任免除》字体大小、字形均与该条文其他文字无明显区别，页面并未提示“《责任免除》”是一个链接。点击“《责任免除》”后弹出页面显示免赔事项包含遗传性疾病。点击“我要投保”后，弹出页面显示被保人信息、付款方式、保险并称、相关协议授权。相关协议授权下有两条，第1条为同意开通按月分期付款功能，第2条为阅读《付款授权》《投保须知》《保险条款》《服务协议》。页面上方的保险名称与相关协议授权六字字体较大且较该页面其他文字更黑；阅读并同意五字字体更小，但颜色较黑；阅读并同意五字后的四个协议名称文字大小与之前文字一致，但颜色更浅。

【裁判结果】

本案争议焦点为在投保人进行电子投保过程中，某保险公司是否已对免责条款进行提示说明，某保险公司是否可以据此拒赔。

《保险法司法解释二》第十二条规定，通过网络、电话等方式订立的保险合同，保险人以网页、音频、视频等形式对免除保险人责任条款予以提示和明确说明的，人民法院可

以认定其履行了提示和明确说明义务。从公证书显示的操作流程看，有投保须知页面，但无如何进入投保须知的页面，无法证明保险人已尽提示说明义务。后续免责条款再次出现，但未在投保过程中予以直接展示，需要投保人点击对应链接进入；而对应链接相较于其所在页面其他文字并不显著，无法起到提示阅读者点击进入的效果。页面中涉及免责条款的内容未体现出被设置了强制阅读。因此，保险人之证据不足以证明其已对免责条款进行提示，对应免责条款不产生效力。故法院判决支持黄某的诉讼请求。

【典型意义】

该案进一步明确了《保险法司法解释二》第十二条在电子投保场景中的适用标准。保险人仅在投保流程中设置免责条款链接、未通过加黑加粗等显著形式突出链接标识，且未设置强制阅读环节的，不能认定其履行了提示说明义务。保险人需对免责条款予以提示和明确说明，不仅要求免责条款内容本身需醒目，引导查看免责条款的链接也应具备足够辨识度，防止保险公司以“已在条款中载明”为由规避保险责任。

【案例九】销售人员代操作投保不能视为履行提示说明义务

——王某、李某诉某保险公司健康保险合同纠纷案

【裁判观点】

投保过程中，保险销售人员代操作投保、投保人仅提供

验证码及个人信息，不能视为保险人对免责条款履行了提示说明义务。

【基本案情】

王某之母李某为王某在某保险公司处投保健康保险。

《保险条款》附表一显示，重大疾病包括颅脑手术：全麻下的开颅手术（以切开硬脑膜为准）。《保险条款》2.4责任免除条款将“被保险人遗传性疾病，先天性畸形、变形或染色体异常”列为免责情形。脚注处释义先天性畸形、变形或染色体异常指被保险人出生时就具有的畸形、变形或染色体异常。先天性畸形、变形或染色体异常依照 ICD-10 确定。

2024 年 2 月 8 日-3 月 13 日，王某住院治疗，被诊断为小脑扁桃体下疝畸形[Arnold-Chiari 综合征]，期间接受显微镜下寰枕畸形减压术。手术记录显示其进行开颅手术，且切开脑硬膜，符合《保险条款》附表一重大疾病中开颅手术的情况。某保险公司认为王某确诊疾病属于先天性畸形，系保险合同中责任免除范畴，故拒赔。

李某提交微信聊天记录证明保险人并未就上述免责条款尽到提示说明义务。2021 年 3 月至 2021 年 7 月，李某与保险销售人张某沟通投保事宜，张某询问王某健康状况（如卵圆孔闭合及动脉导管闭合的检查报告、肺炎住院病例），李某予以回复，并附上出院诊断证明书的文件。2021 年 6 月 18 日，张某发送包括案涉保险在内的四个投保链接，李某回复投保信息文件。张某协助代操作投保，李某提供验证码并

提供投保所需个人信息。李某曾询问保单形式，张某回复可自行打印电子保单，后案涉保险投保完成。

【裁判结果】

本案的争议焦点有二：一、王某所确诊小脑扁桃体下疝畸形[Arnold-Chiari 综合征]是否为先天性畸形；二、某保险公司是否应承担保险责任。

关于争议焦点一。《保险条款》脚注载明，先天性畸形依照 ICD-10 确定。结合 ICD-10、医保数据库疾病编码查询截图，王某所患疾病属于编码开头 Q07 的神经系统其他先天性畸形，符合免责条款项下先天性畸形的定义。

关于争议焦点二。《保险条款》2.4.2（7）约定属于免除保险人责任的条款。李某提交的微信聊天记录未显示投保过程中某保险公司就案涉保险免责条款对李某进行了提示说明，某保险公司亦未提交其就免责条款履行提示说明义务的证据，某保险公司应当承担举证不能的不利后果。故李某提出免责条款依法对其不发生效力的意见，法院予以采纳，某保险公司无权以王某所患疾病为先天性畸形为由拒赔并终止保险合同。某保险公司应依据《保险条款》2.3.1.1 首次重大疾病保险金及附表一关于重大疾病的约定承担保险责任。综上，法院支持了原告的诉讼请求。

【典型意义】

实际操作中，部分保险公司销售人员存在代操作投保等销售不规范情形。投保人在投保过程中应当自行完成投保操作，主动关注保险条款，对不理解的免责内容及时向保险公

司咨询并留存沟通记录，截图保存关键页面、下载完整保单，维护自身知情权，不要轻信销售人员口头承诺。此外，保险公司也应规范销售人员的销售行为，对销售人员开展提示说明义务专项培训，规范电子投保流程，增设弹窗突出提示、免责条款强制阅读、单独确认勾选等投保页面，确保投保人在阅读并确认后才能进入下一环节，保护投保人的知情权与选择权。

【案例十】引用重疾险等待期条款拒赔的认定

——王某诉某保险公司健康保险合同纠纷案

【裁判观点】

重疾险等待期条款中“等待期届满前接受医学检查或治疗，延续至等待期后确诊同一疾病”的适用，应严格以疾病本质属性一致为标准，保险人不得以不同疾病拒赔。

【基本案情】

2022 年 7 月 29 日，医院彩超检查报告单，载明王某临床诊断为乳房结节，超声诊断为双乳多发结节 BI-RADS3 类。

王某向某保险公司投保重大疾病保险，被保险人王某，基本保险金额 300 000 元，合同生效日 2022 年 7 月 31 日。健康告知补充页载明：存在乳腺结节；有 1 年内超声或钼靶检查，并且检查报告中不存在 BI-RADS 分级 4-6 级：是。核保结论：正常承保。

保险条款约定，2.3 等待期设置：本公司将对一段时间内发生的保险事故不承担给付保险金的责任，这段时间称为

等待期。除另有约定外，自本合同生效之日起（合同复效的则自最后一次复效之日起）90 天为等待期。发生以下一个或者多个情形时，本公司不承担保险责任，并向投保人无息返还已交纳的保险费，同时本合同效力终止：1）等待期届满前被保险人发生本合同约定的一种或多种轻度疾病、中度疾病、重度疾病；2）等待期届满前被保险人接受医学检查或治疗，且延续至等待期满后确诊发生同一种疾病，且该疾病符合本合同约定的轻度疾病、中度疾病或重度疾病；3）等待期届满前被保险人身故。

2022 年 9 月 28 日，医院作出超声检查报告，检查提示王某双乳增生，左乳多发实性结节，BI-RADS3，双乳多发囊肿。

2023 年 2 月 13 日，医院出具彩色病理图文报告，载明左乳部分下方：……结合免疫组化即分子检测结果，符合腺样囊性癌，经典型（腺肌上皮瘤恶变）。某保险公司拒赔。王某诉请法院要求给付保险金。某保险公司认为，王某于 2022 年 9 月就诊提示左乳多发实性结节，BI-RADS3，本次疾病属于等待期 90 天内接受医学检查或治疗，且延续至等待期后确诊合同约定的重大疾病情形，保险人有权不承担给付保险金的责任，保险合同已经终止。

【裁判结果】

本案争议焦点在于应否适用等待期条款约定的不予理赔的情形，即等待期届满前被保险人接受医学检查或治疗，且延续至等待期届满后确诊发生同一疾病。对此，法院认为

本案不适用前述条款。结节、囊肿虽存在癌变的可能性，但一般乳腺疾病与乳腺癌变并不属于同一疾病。王某于等待期内检查提示双乳多发囊肿，与其在等待期后确诊的腺样囊性癌，经典型（腺肌上皮瘤恶变）并非同一种疾病，本案不符合等待期条款约定情况。某保险公司应按照约定支付保险金。综上，法院支持了原告的诉讼请求。

【典型意义】

部分保险公司常将等待期内的轻微疾病检查与期满后确诊的重大疾病简单归为“同一疾病”，以此拒绝赔付，引发纠纷。等待期条款中“等待期届满前接受检查或治疗，延续至期满后确诊同一疾病”的约定，需以“疾病本质属性一致”为判断依据，且遵循普通投保人的合理认知，避免通过扩大解释限缩理赔范围。保险人主张适用等待期条款时，需举证证明等待期内的检查或治疗与等待期后确诊疾病在本质属性上具有一致性。若保险人不能提供充分证据证明两者为同一疾病，则法院对其适用等待期条款的抗辩理由不予采纳，保险人应当履行赔付义务。